UE B2 · SEMESTRE 1

Psychopathologie — QCM

Cochez les propositions exactes. Une à trois réponses sont justes par question.
Le nombre attendu est précisé. Les corrigés argumentés sont regroupés à la fin.

113 QCM | 11 thèmes | Corrigés à la fin

Fondements, normalité et causalité

Q01 **Quels objets relèvent de l'étude psychopathologique ? (2 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. L'expérience singulière de la souffrance psychique.
- [ ] B. La description et les mécanismes des troubles psychiques.
- [ ] C. L'attribution d'un diagnostic à toute conduite inhabituelle.
- [ ] D. La seule mesure des performances intellectuelles.
- [ ] E. La recherche exclusive d'une cause biologique unique.

Q02 **Quelles formulations correspondent aux définitions de la psychopathologie présentées dans le cours ? (3 bonnes réponses)** Intermédiaire

- [ ] A. Ménéchal met au centre la souffrance psychique.
- [ ] B. Pedinielli inclut évaluation, diagnostic, aide et traitement de la souffrance.
- [ ] C. Tous les auteurs réduisent son champ aux conduites déviantes.
- [ ] D. La psychopathologie exclut tout travail sur l'évolution.
- [ ] E. Piéron inclut description, classification, mécanismes et évolution des troubles.

Q03 **Quelles associations respectent les trois axes de Lantéri-Laura ? (3 bonnes réponses)** Intermédiaire

- [ ] A. Psychologie du pathologique : compréhension globale de l'expérience du patient.
- [ ] B. Psychologie du pathologique : mesure exclusive d'une lésion cérébrale.
- [ ] C. Clinique du pathologique : singularité de l'expérience de souffrance.
- [ ] D. Pathologie du psychologique : étude des aspects inhabituels ou morbides.
- [ ] E. Clinique du pathologique : suppression de toute information individuelle.

Q04 Facile

Une personne pleure après un décès. Quelle conclusion est justifiée à partir de ce seul fait ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. La seule fréquence statistique des pleurs détermine le diagnostic.
- ☐ B. L'originalité de sa manière de pleurer suffit au diagnostic.
- ☐ C. Toute tristesse de deuil exclut définitivement une pathologie.
- ☐ D. Il faut explorer le contexte, la durée et le retentissement avant de conclure.
- ☐ E. Une dépression caractérisée est nécessairement présente.

Q05 Facile

Un patient dit souhaiter mourir, mais paraît calme. Quelles attitudes correspondent aux repères du cours ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Prendre sa parole au sérieux.
- ☐ B. Conclure que cette parole est normale car elle est fréquente.
- ☐ C. Attendre une conduite dangereuse pour en parler.
- ☐ D. Écarter sa plainte puisqu'il ne pleure pas.
- ☐ E. Transmettre cette information à l'équipe pour son évaluation.

Q06 Intermédiaire

Quels paramètres doivent être croisés pour apprécier le normal et le pathologique ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. L'intensité, la durée et le retentissement de la souffrance.
- ☐ B. Les limitations et les dangers pour soi ou pour autrui.
- ☐ C. La conformité à toutes les préférences personnelles du soignant.
- ☐ D. Le rapport à la réalité dans son contexte culturel.
- ☐ E. L'absence de toute originalité dans la conduite.

Q07 Intermédiaire

Une personne ne reconnaît pas son trouble alors que son entourage décrit des difficultés majeures. Quelles propositions sont exactes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Une anosognosie peut contribuer à l'absence de plainte personnelle.
- ☐ B. Les observations de l'entourage peuvent être pertinentes.
- ☐ C. L'anosognosie est nécessairement un mensonge délibéré.
- ☐ D. L'avis de l'entourage suffit à établir tous les diagnostics.
- ☐ E. L'absence de plainte prouve l'absence de trouble.

Q08 Intermédiaire

Quelles distinctions concernant culture, déviance et rareté sont correctes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Une conduite déviante au regard d'une norme n'est pas automatiquement une maladie.
- [ ] B. Une croyance culturellement partagée exclut tout examen du retentissement.
- [ ] C. Une croyance doit être située dans son environnement culturel.
- [ ] D. Un comportement rare est nécessairement pathologique.
- [ ] E. La déviance a une définition universelle indépendante des époques.

Q09 Facile

Que désigne la pathoplasticité ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. La variation de l'expression d'un trouble selon les sujets et les contextes.
- [ ] B. L'existence d'une cause unique pour toutes les maladies.
- [ ] C. La présence du même symptôme à l'identique dans toutes les cultures.
- [ ] D. La fabrication volontaire de symptômes pour tromper.
- [ ] E. La disparition certaine de tout trouble après un changement de milieu.

Q10 Intermédiaire

Quelles explications de la variabilité du pathologique sont données dans le cours ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Le point de vue de l'observateur n'intervient jamais.
- [ ] B. Les connaissances issues du suivi des patients évoluent.
- [ ] C. Des grilles théoriques différentes orientent l'observation.
- [ ] D. Les normes et les significations culturelles modifient la lecture d'un vécu.
- [ ] E. La signification des troubles reste identique à toute époque.

Q11 Intermédiaire

Quelles associations entre hypothèse étiologique et facteur privilégié sont exactes ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Psychogenèse : preuve que la personne invente sa souffrance.
- [ ] B. Psychogenèse : facteurs et mécanismes psychologiques.
- [ ] C. Sociogenèse : transmission exclusivement génétique.
- [ ] D. Sociogenèse : facteurs sociaux pouvant favoriser les troubles.
- [ ] E. Organogenèse : facteurs organiques et fonctionnement cérébral.

Q12 Difficile

Que permet une lecture bio-psycho-sociale ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Articuler vulnérabilité biologique, histoire psychique et contexte social.
- [ ] B. Comprendre qu'un facteur psychologique puisse avoir des effets corporels.
- [ ] C. Considérer que biologique et psychologique s'excluent par définition.
- [ ] D. Déduire une origine psychique de tout examen sans anomalie.
- [ ] E. Remplacer l'analyse clinique par un facteur social unique.

Approches thérapeutiques et apprentissages

Q13 **Quelles associations respectent la typologie des approches présentée dans le cours ? (3 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. Approche syncrétique : refus de combiner plusieurs démarches.
- [ ] B. Approche systémique : étude exclusive d'une lésion anatomique.
- [ ] C. Approche personnaliste : attention portée au sujet et aux facteurs individuels.
- [ ] D. Approche interactionniste : relations entre personne et contexte.
- [ ] E. Approche environnementaliste : situation, culture et environnement.

Q14 **Dans une lecture biologique du symptôme, quelles propositions sont cohérentes ? (2 bonnes réponses)** Intermédiaire

- [ ] A. Considérer le symptôme comme toujours simulé.
- [ ] B. Ne pas réduire toute la compréhension du patient à ce seul niveau.
- [ ] C. Expliquer tout trouble par la seule volonté du patient.
- [ ] D. Exclure par principe tout rôle du contexte ou de la relation.
- [ ] E. Rechercher des modifications du fonctionnement du système nerveux.

Q15 **Quelle proposition décrit le conditionnement classique ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Un stimulus initialement neutre peut, après association, déclencher une réponse.
- [ ] B. Un souvenir est maintenu hors de la conscience par refoulement.
- [ ] C. Le thérapeute étudie seulement les règles d'un système familial.
- [ ] D. Une conduite s'apprend exclusivement par observation d'un modèle.
- [ ] E. Un comportement est modifié uniquement par ses conséquences futures.

Q16 **Un comportement devient plus fréquent parce que ses conséquences le favorisent. Quelles notions sont pertinentes ? (2 bonnes réponses)** Intermédiaire

- [ ] A. Le mécanisme décrit une représentation refoulée.
- [ ] B. La conséquence est nécessairement agréable pour être qualifiée par sa fonction.
- [ ] C. Le renforcement.
- [ ] D. L'apprentissage vicariant est la seule explication possible.
- [ ] E. Le conditionnement opérant.

Q17 Intermédiaire

Un enfant apprend en observant une conduite et ce qui arrive à celui qui l'accomplit. Quelles propositions sont exactes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. L'environnement ne joue aucun rôle dans cet exemple.
- ☐ B. L'apprentissage est dit vicariant.
- ☐ C. Le terme signifie que tous les apprentissages sont inconscients au sens freudien.
- ☐ D. L'enfant n'a pas besoin de subir lui-même chaque conséquence pour apprendre.
- ☐ E. Il s'agit nécessairement d'un instinct hérité.

Q18 Intermédiaire

Quelles propositions caractérisent la lecture comportementale du symptôme ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Elle utilise nécessairement une interprétation des fantasmes œdipiens.
- ☐ B. Elle considère tout comportement problématique comme fixé dès la naissance.
- ☐ C. Elle recherche ce qui maintient actuellement la conduite.
- ☐ D. Elle examine les conditions d'acquisition d'un comportement.
- ☐ E. Elle peut viser un réapprentissage.

Q19 Intermédiaire

Dans une lecture systémique, quelles propositions sont justes ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Les réactions d'une personne peuvent influencer les réponses des autres.
- ☐ B. Les ressources du système peuvent être mobilisées pour un changement.
- ☐ C. La famille constitue automatiquement la cause unique de chaque trouble.
- ☐ D. Le patient désigné est nécessairement responsable volontaire de la souffrance familiale.
- ☐ E. Le patient désigné est le porteur du symptôme dans un système relationnel.

Q20 Facile

Que signifie métacommuniquer ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Échanger sur la manière dont on communique.
- ☐ B. Se limiter au sens littéral des mots sans examiner l'échange.
- ☐ C. Faire varier une dose médicamenteuse.
- ☐ D. Interdire toute parole sur les malentendus.
- ☐ E. Poser un diagnostic à partir d'un seul geste.

Q21 Difficile

Quelles distinctions sur le travail systémique sont correctes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Le professionnel doit trouver seul la solution en ignorant les ressources familiales.
- ☐ B. La métacommunication consiste à supprimer les relations entre les membres.
- ☐ C. Le travail avec les proches ne suppose pas toujours que tous soient réunis.
- ☐ D. Le système doit nécessairement être entièrement modifié dès la première séance.
- ☐ E. Un changement peut d'abord concerner certains éléments au sein du système.

Q22 **Quelles dimensions les TCC articulent-elles dans la présentation du cours ? (3 bonnes réponses)** Intermédiaire

- [ ] A. Les apprentissages et les comportements.
- [ ] B. Les émotions et leur régulation.
- [ ] C. L'interdiction d'évaluer les progrès.
- [ ] D. Une théorie faisant de l'environnement le seul élément pertinent.
- [ ] E. Les pensées, croyances et schémas cognitifs.

Q23 **Une personne interprète les situations comme toujours dangereuses et évite de sortir. Quels liens sont cohérents avec la lecture TCC ? (2 bonnes réponses)** Intermédiaire

- [ ] A. Des schémas cognitifs peuvent orienter l'interprétation du danger.
- [ ] B. L'évitement prouve à lui seul une perte de contact avec la réalité.
- [ ] C. Interprétations, émotions et évitements peuvent se maintenir réciproquement.
- [ ] D. Cette description suffit à démontrer un désir inconscient précis.
- [ ] E. Un biais cognitif est nécessairement une tromperie volontaire.

Q24 **Quelles propositions décrivent correctement le déroulement des TCC présenté dans le cours ? (3 bonnes réponses)** Difficile

- [ ] A. L'acceptation peut être travaillée lorsque tout ne peut pas être modifié.
- [ ] B. Les buts et moyens sont définis avec le patient.
- [ ] C. Les distances citées dans un exemple d'exposition constituent un protocole universel.
- [ ] D. Les exercices sont adaptés au problème et réévalués.
- [ ] E. Le nombre de séances est fixe pour tous les troubles et toutes les personnes.

Psychanalyse, histoire et formations de l'inconscient

Q25 **Quels sont les trois sens de la psychanalyse retenus dans le cours ? (3 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. Une méthode de traitement.
- [ ] B. Une méthode dont l'objet exclusif est la mesure des réflexes.
- [ ] C. Un procédé d'investigation du psychisme inconscient.
- [ ] D. Une classification anatomique des régions du cerveau.
- [ ] E. Une théorie issue de cette expérience.

Q26 **Dans la présentation historique de l'hystérie, quelles distinctions doivent être conservées ? (2 bonnes réponses)**

Intermédiaire

- ☐ A. Le corps fantasmatique désigne un corps représenté et investi psychiquement.
- ☐ B. Toute paralysie appartient à l'hystérie.
- ☐ C. Tout examen sans anomalie prouve une conversion.
- ☐ D. Un trouble fonctionnel peut être réellement vécu sans simulation.
- ☐ E. Une apparente indifférence démontre que le symptôme est volontaire.

Q27 **Quelles propositions respectent la description historique de la grande crise par Charcot ? (2 bonnes réponses)**

Intermédiaire

- ☐ A. Les prodromes précèdent les quatre périodes décrites.
- ☐ B. La période de contorsions est aussi désignée comme clownisme.
- ☐ C. La phase terminale précède les prodromes.
- ☐ D. La description établit qu'une crise de ce type est toujours une épilepsie.
- ☐ E. Les prodromes sont comptés comme la première des quatre périodes.

Q28 **Quelles associations concernant Anna O. et la méthode cathartique sont correctes ? (2 bonnes réponses)**

Facile

- ☐ A. La méthode historique donne une garantie de guérison de toute maladie.
- ☐ B. Abréaction : décharge émotionnelle d'un affect lié à une expérience pénible.
- ☐ C. Talking cure : cure par la parole.
- ☐ D. État hypnoïde : preuve d'une simulation consciente.
- ☐ E. Catharsis : suppression de toute possibilité de parler.

Q29 **Quelles distinctions entre théorie de la séduction et théorie du fantasme sont correctes ? (3 bonnes réponses)**

Intermédiaire

- ☐ A. Un fantasme suffit à prouver un événement matériel précis.
- ☐ B. La découverte de fantasmes exclut toute histoire traumatique.
- ☐ C. La seconde reconnaît le rôle de scénarios et désirs dans la réalité psychique.
- ☐ D. La théorie du fantasme ne permet pas de nier une violence subie.
- ☐ E. La première relie certaines névroses à des traumatismes sexuels précoces.

Q30 Intermédiaire

Quelles propositions caractérisent les formations de compromis dans le modèle psychanalytique ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Elles prouvent qu'un acte manqué isolé est une maladie.
- ☐ B. Elles supposent toujours une décision consciente de produire le symptôme.
- ☐ C. Elles désignent une négociation administrative entre professionnels.
- ☐ D. Un symptôme peut à la fois maintenir quelque chose du désir et exprimer l'interdit.
- ☐ E. Elles expriment de manière transformée des exigences opposées.

Q31 Facile

Quelle distinction entre contenu manifeste et contenu latent du rêve est exacte ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Le manifeste possède le même sens certain pour toute personne.
- ☐ B. Un dictionnaire universel suffit à interpréter le rêve.
- ☐ C. Le manifeste est toujours caché au rêveur et le latent est son récit au réveil.
- ☐ D. Le manifeste correspond au rêve vécu et raconté ; le latent aux contenus sous-jacents.
- ☐ E. Le latent est une lésion repérable sur une image cérébrale.

Q32 Intermédiaire

Quelles associations concernant le travail du rêve sont correctes ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Figuration : pensées rendues représentables sous forme d'images.
- ☐ B. Élaboration secondaire : suppression de toute organisation du récit.
- ☐ C. Déplacement : intensité reportée d'une représentation vers une autre.
- ☐ D. Reste diurne : souvenir qui ne peut jamais participer au rêve.
- ☐ E. Condensation : plusieurs éléments réunis dans un même élément.

Q33 Difficile

Un symptôme s'atténue, puis une autre manifestation apparaît. Quelles lectures respectent les limites du cours ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Le patient choisit forcément consciemment sa nouvelle manifestation.
- ☐ B. Une migration du symptôme est une possibilité décrite, pas une règle universelle.
- ☐ C. Il faut en conclure que toute amélioration symptomatique est nuisible.
- ☐ D. Tout traitement doit être refusé afin de préserver le symptôme.
- ☐ E. La fonction du symptôme et les autres moyens d'élaboration méritent d'être explorés.

Q34 Intermédiaire

Quelles propositions concernent les lapsus et les actes manqués ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Un acte manqué est nécessairement une tromperie volontaire.
- [ ] B. Toute erreur quotidienne permet de diagnostiquer une structure.
- [ ] C. Un lapsus fournit toujours une vérité certaine sans exploration.
- [ ] D. Le lapsus concerne notamment une erreur de parole ou d'écriture.
- [ ] E. Un acte manqué peut concerner un oubli ou une action qui manque son but conscient.

Q35 Intermédiaire

Concernant la méthode psychanalytique, quelles propositions sont exactes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. L'association libre consiste à apprendre une liste de réponses obligatoires.
- [ ] B. L'association libre invite à dire ce qui vient à l'esprit sans sélection volontaire préalable.
- [ ] C. Une interprétation repose uniquement sur un dictionnaire universel de symboles.
- [ ] D. La résistance désigne des forces qui s'opposent à l'accès ou au travail de certains contenus.
- [ ] E. La résistance doit toujours être comprise comme une provocation délibérée.

Pulsions et appareil psychique

Q36 Facile

Dans le modèle freudien, quels sont les quatre caractères de la pulsion ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. La mémoire et la perception.
- [ ] B. La source et la poussée.
- [ ] C. Le but et l'objet.
- [ ] D. Le diagnostic et le pronostic.
- [ ] E. L'intelligence et la volonté.

Q37 Intermédiaire

Quelle proposition distingue correctement pulsion, instinct et impulsion ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. L'impulsion prouve à elle seule une psychose.
- [ ] B. Toute pulsion entraîne immédiatement un passage à l'acte.
- [ ] C. La pulsion impose toujours un comportement biologiquement programmé.
- [ ] D. L'impulsion désigne une poussée à agir, sans être synonyme de pulsion psychanalytique.
- [ ] E. L'instinct est une décision longuement réfléchie.

Q38 Intermédiaire

Concernant affect et représentation, quelles propositions sont exactes ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Une représentation est nécessairement une photographie consciente.
- [ ] B. L'affect correspond à la tonalité émotionnelle de l'expérience.
- [ ] C. Les représentations de mots et de choses sont distinguées dans le modèle.
- [ ] D. L'affect et la représentation sont toujours indissociables dans leurs destins.
- [ ] E. La représentation est le contenu psychique lié à un objet ou à une expérience.

Q39 Facile

Que signifie la notion d'appareil psychique dans la fiche ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Il s'agit d'un modèle théorique du fonctionnement psychique.
- [ ] B. Il s'agit d'un test qui suffit à poser un diagnostic.
- [ ] C. Il s'agit d'un organe localisé par l'imagerie cérébrale.
- [ ] D. Il correspond uniquement au système nerveux autonome.
- [ ] E. Il désigne une mesure de l'intelligence.

Q40 Intermédiaire

Dans la première topique freudienne, quelles propositions sont exactes ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Le préconscient contient des éléments susceptibles de devenir conscients.
- [ ] B. Le système perception-conscience n'est pas conçu comme le lieu durable de stockage des traces.
- [ ] C. Tout ce qui est momentanément oublié est nécessairement refoulé.
- [ ] D. L'inconscient fonctionne notamment selon les processus primaires.
- [ ] E. Le préconscient et l'inconscient sont deux noms d'un même système.

Q41 Difficile

Quelles caractéristiques sont attribuées à l'inconscient dans le modèle freudien ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. La disparition automatique de tout désir ancien avec l'âge.
- [ ] B. L'absence de temporalité au sens de l'organisation consciente du temps.
- [ ] C. La coexistence de tendances contradictoires.
- [ ] D. L'obligation de vérifier chaque représentation dans la réalité extérieure.
- [ ] E. La prédominance du doute logique et de la négation consciente.

Q42 **Quelle distinction entre censure et pare-excitation est correcte ? (1 bonne réponse)** Intermédiaire

- [ ] A. La censure filtre le passage entre systèmes ; le pare-excitation protège contre un excès d'excitations.
- [ ] B. Un traumatisme implique toujours une lésion cérébrale visible.
- [ ] C. La censure est exclusivement une interdiction légale extérieure.
- [ ] D. Censure et pare-excitation sont strictement synonymes.
- [ ] E. Le pare-excitation supprime définitivement tout affect.

Q43 **Dans la seconde topique, quelles fonctions sont correctement attribuées ? (3 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. Le Moi est intégralement conscient.
- [ ] B. Le Surmoi est lié à l'intériorisation d'interdits et d'exigences.
- [ ] C. Le Moi assure des médiations entre exigences pulsionnelles, Surmoi et réalité.
- [ ] D. Le Ça délibère selon des normes morales.
- [ ] E. Le Ça est le pôle pulsionnel, entièrement inconscient.

Q44 **Quelles précisions évitent de confondre les deux topiques ? (2 bonnes réponses)** Difficile

- [ ] A. L'inconscient disparaît lorsque la seconde topique est proposée.
- [ ] B. Le Moi correspond exactement au conscient et à lui seul.
- [ ] C. Le Moi et le Surmoi comportent des dimensions inconscientes.
- [ ] D. La culpabilité et la honte ne sont pas de simples synonymes.
- [ ] E. Le Surmoi est toujours une autorité extérieure réelle.

Q45 **Quelle lecture de la carence du préconscient respecte la portée de l'exemple oral ? (1 bonne réponse)** Difficile

- [ ] A. Elle prouve que tout passage à l'acte est volontairement calculé.
- [ ] B. Elle constitue la définition suffisante de toute addiction.
- [ ] C. Elle est une hypothèse de difficulté à mobiliser des représentations trop chargées d'affects, pouvant favoriser l'action à la place de l'élaboration.
- [ ] D. Elle rend inutile l'étude du contexte.
- [ ] E. Elle signifie absence anatomique d'une région appelée préconscient.

Économie psychique et conflits

Q46 **Que décrivent les points de vue économique et dynamique ? (2 bonnes réponses)** Intermédiaire

- [ ] A. Les deux points de vue excluent la topique.
- [ ] B. L'économique considère la quantité, la circulation et la liaison de l'excitation.
- [ ] C. Le dynamique signifie seulement que le patient bouge beaucoup.
- [ ] D. L'économique se limite aux revenus du patient.
- [ ] E. Le dynamique considère les forces en conflit et leurs effets.

Q47 **Concernant les principes de plaisir, de réalité et de constance, quelles propositions sont exactes ? (3 bonnes réponses)** Intermédiaire

- [ ] A. Le principe de réalité permet de différer ou de modifier la satisfaction.
- [ ] B. Le principe de réalité élimine définitivement toute recherche de plaisir.
- [ ] C. Attendre une satisfaction est une capacité toujours acquise dès la naissance.
- [ ] D. Le principe de constance tend au maintien d'un niveau d'excitation aussi bas que possible.
- [ ] E. Le principe de plaisir tend à réduire le déplaisir lié à la tension.

Q48 **Quelle proposition définit correctement la libido ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Elle signifie absence de conflit psychique.
- [ ] B. Elle désigne l'énergie des pulsions sexuelles au sens psychanalytique.
- [ ] C. Elle est nécessairement consciente et volontaire.
- [ ] D. Elle désigne toute consommation alimentaire.
- [ ] E. Elle mesure uniquement le nombre de partenaires.

Q49 **Quels rapprochements concernant investissements et processus psychiques sont exacts ? (2 bonnes réponses)** Intermédiaire

- [ ] A. L'investissement narcissique concerne le Moi ; l'investissement objectal concerne un objet.
- [ ] B. Les processus primaires reposent exclusivement sur la logique rationnelle.
- [ ] C. L'investissement objectal concerne nécessairement un objet matériel.
- [ ] D. La répétition porte toujours sur une expérience agréable.
- [ ] E. Les processus secondaires sont associés à la liaison et à la prise en compte de la réalité.

Q50 Difficile

Concernant les deux théories pulsionnelles freudiennes, quelles propositions sont exactes ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. L'intrication désigne la combinaison des tendances pulsionnelles.
- [ ] B. Une première opposition distingue pulsions d'autoconservation et pulsions sexuelles.
- [ ] C. La seconde oppose pulsions de vie et pulsions de mort.
- [ ] D. Les pulsions de mort permettent de prédire seules un acte individuel.
- [ ] E. Les deux théories sont deux dosages biologiques de routine.

Q51 Intermédiaire

Un nourrisson continue à suçoter après avoir été nourri. Quel concept ce cas illustre-t-il dans le modèle présenté ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Une équivalence entre faim et toute forme de désir.
- [ ] B. L'étayage de la satisfaction sexuelle infantile sur une fonction d'autoconservation.
- [ ] C. Une preuve suffisante de trouble psychiatrique.
- [ ] D. Un choix conscient de sublimation artistique.
- [ ] E. L'absence de toute satisfaction corporelle.

Q52 Intermédiaire

Concernant répétition et deuil, quelles propositions sont exactes ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Répéter une situation pénible signifie nécessairement la vouloir consciemment.
- [ ] B. L'introjection peut soutenir la capacité de supporter une séparation.
- [ ] C. La répétition peut porter sur des expériences pénibles.
- [ ] D. Le travail de deuil implique un remaniement des investissements.
- [ ] E. Un deuil exige l'effacement total de tous les souvenirs.

Développement psychoaffectif

Q53 Intermédiaire

Quelles précautions concernent les stades du développement présentés dans la fiche ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Chaque stade efface entièrement le précédent.
- [ ] B. Fixation et régression sont des concepts distincts.
- [ ] C. Un stade fournit à lui seul la cause unique d'une pathologie.
- [ ] D. Un comportement isolé permet d'attribuer définitivement un stade à un adulte.
- [ ] E. Les limites d'âge sont indicatives et les organisations peuvent se chevaucher.

Q54 Facile

Concernant l'organisation orale, quelles propositions sont exactes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. L'oralité exclut toute ambivalence dans ses différentes phases.
- [ ] B. La satisfaction orale se limite à la valeur nutritive du lait.
- [ ] C. La zone orale est centrale dans la satisfaction.
- [ ] D. L'incorporation constitue un but caractéristique.
- [ ] E. L'objet y est nécessairement perçu comme une personne totale et séparée.

Q55 Intermédiaire

Quels éléments se rattachent à l'organisation anale décrite ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. La rétention et l'expulsion.
- [ ] B. Les fèces comme objet d'échange dans la relation.
- [ ] C. L'ambivalence et les limites dedans-dehors.
- [ ] D. La disparition de tout enjeu de maîtrise.
- [ ] E. Une organisation qui apparaît exclusivement après la puberté.

Q56 Difficile

Concernant le stade phallique du modèle historique, quelles propositions sont exactes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Toute curiosité corporelle de l'enfant prouve une violence sexuelle.
- [ ] B. L'absence de limites éducatives est une conséquence nécessaire du modèle.
- [ ] C. Le monisme phallique est une vérité anatomique actuelle incontestée.
- [ ] D. Il met notamment en jeu la puissance et la différence des sexes.
- [ ] E. Il est encore prégénital au sens du modèle.

Q57 Intermédiaire

Quels éléments décrivent le complexe d'Œdipe dans la présentation du cours ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Il implique des désirs et des rivalités dans une relation triangulaire.
- [ ] B. Ses formes positive et négative peuvent coexister dans la forme complète.
- [ ] C. Il décrit exclusivement une relation à deux sans tiers.
- [ ] D. Il permet de connaître avec certitude l'histoire réelle d'un patient.
- [ ] E. Les identifications participent à son remaniement.

Q58 Facile

Que caractérise la période de latence dans la fiche ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Elle signifie arrêt de tout développement psychique.
- [ ] B. Elle favorise notamment apprentissages et sublimations entre l'enfance œdipienne et la puberté.
- [ ] C. Elle commence uniquement à l'âge adulte.
- [ ] D. Elle correspond nécessairement à une amnésie globale.
- [ ] E. Elle garantit l'absence de tout conflit.

Q59 Intermédiaire

Quelles propositions concernent l'adolescence dans le modèle présenté ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Toute réactivation de conflit est une maladie.
- [ ] B. De nouveaux choix d'objets et remaniements identificatoires peuvent survenir.
- [ ] C. La puberté remanie les investissements et réactive des conflits antérieurs.
- [ ] D. L'adolescence efface toute l'histoire infantile.
- [ ] E. Les identifications sont définitivement achevées avant la puberté.

Q60 Intermédiaire

Quels rapprochements sont corrects ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Le narcissisme désigne toujours une maladie.
- [ ] B. L'autoérotisme suppose obligatoirement un projet conscient.
- [ ] C. L'autoérotisme concerne une satisfaction sur le corps propre, liée à des pulsions partielles.
- [ ] D. L'amour d'objet est nécessairement l'amour d'un objet matériel.
- [ ] E. Le narcissisme concerne l'investissement du Moi.

Q61 Intermédiaire

Quelles distinctions sont correctes dans le modèle des stades oraux ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Les deux temps correspondent à des lésions digestives.
- [ ] B. Le temps oral primitif privilégie la succion et une faible différenciation sujet-objet.
- [ ] C. Une morsure isolée révèle avec certitude une pathologie.
- [ ] D. Le sevrage efface instantanément toute modalité orale.
- [ ] E. Le temps sadique-oral introduit notamment morsure et ambivalence.

Q62 Intermédiaire

Quelles propositions concernent les théories sexuelles infantiles décrites ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Le modèle évoque notamment des explications de la fécondation et de la naissance.
- [ ] B. Elles attestent automatiquement un événement sexuel vécu.
- [ ] C. Elles suffisent à diagnostiquer un trouble mental.
- [ ] D. Elles imposent de confirmer à l'enfant une anatomie erronée.
- [ ] E. Elles illustrent des explications construites par l'enfant avec les représentations dont il dispose.

Q63 Intermédiaire

Concernant l'accompagnement d'une personne ayant subi des violences ou mutilations sexuelles, quels repères figurent dans la fiche ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Écouter son vécu et sa demande en tenant compte du moment où elle peut en parler.
- ☐ B. Déduire un projet opératoire du seul intitulé de la violence.
- ☐ C. Imposer un récit détaillé immédiat à toute personne.
- ☐ D. Considérer qu'une intervention chirurgicale règle nécessairement tout le vécu traumatique.
- ☐ E. Informer sur l'accès à des consultations spécialisées adaptées.

Angoisses et organisations psychiques

Q64 Facile

Quelle proposition distingue le mieux peur et angoisse dans la fiche ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. La peur est nécessairement dépourvue de manifestations corporelles.
- ☐ B. L'angoisse est une décision volontaire.
- ☐ C. La peur se rapporte à un danger identifié ; l'angoisse peut être plus diffuse, sans objet clairement repéré.
- ☐ D. Toute angoisse signifie psychose.
- ☐ E. L'angoisse est toujours simulée lorsqu'aucun danger extérieur n'est visible.

Q65 Intermédiaire

Quels vécus sont correctement associés ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. L'angoisse de perte d'objet est toujours la perte d'un objet matériel.
- ☐ B. L'angoisse de castration peut concerner une atteinte à la puissance ou à l'autonomie.
- ☐ C. L'angoisse de morcellement concerne notamment la désintégration corporelle ou identitaire.
- ☐ D. L'angoisse de perte d'objet concerne la crainte de perdre l'objet d'amour.
- ☐ E. Un vécu de morcellement suffit à prouver une structure psychotique.

Q66 Difficile

Comment distinguer les deux théories freudiennes de l'angoisse présentées ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Dans la première, l'angoisse est envisagée comme une conséquence du refoulement.
- ☐ B. Dans les deux théories, toute angoisse est volontaire.
- ☐ C. Dans la seconde, l'angoisse-signal alerte le Moi et peut déclencher des défenses.
- ☐ D. La première affirme que la représentation et l'affect sont toujours refoulés de manière identique.
- ☐ E. La seconde théorie supprime toute fonction d'alarme.

Q67 Intermédiaire

Que signifie la métaphore du cristal appliquée à la structure ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Elle évoque une organisation dont les lignes de fragilité peuvent apparaître lors d'une décompensation.
- [ ] B. Elle constitue une observation anatomique du cerveau.
- [ ] C. Elle rend inutile toute observation clinique.
- [ ] D. Elle permet un diagnostic certain à partir d'une seule parole.
- [ ] E. Elle affirme qu'une personne est toujours symptomatique.

Q68 Intermédiaire

Dans la présentation structurale historique, quelles propositions sont exactes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. La névrose signifie absence de trouble et de souffrance.
- [ ] B. Les catégories structurales se superposent exactement aux diagnostics du DSM.
- [ ] C. La psychose peut comporter une altération du rapport à la réalité.
- [ ] D. Un mécanisme de défense suffit toujours à déterminer la structure.
- [ ] E. La névrose est généralement associée à un contact avec la réalité globalement préservé.

Q69 Difficile

Concernant les états limites dans le modèle de Bergeret, quelles propositions sont exactes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Ils se déduisent du seul fait d'avoir peur d'être abandonné.
- [ ] B. La dépendance anaclitique renvoie à un besoin d'appui sur l'objet.
- [ ] C. Le terme signifie nécessairement un épisode psychotique permanent.
- [ ] D. Ils sont strictement identiques à toute définition DSM du trouble borderline.
- [ ] E. Ils sont présentés comme une organisation intermédiaire, dite astructuration.

Q70 Difficile

Quelles associations respectent le tableau structural du cours, sans constituer un diagnostic à elles seules ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Angoisse de perte d'objet et relation anaclitique des états limites.
- [ ] B. Angoisse de castration et organisation névrotique, avec une place du refoulement.
- [ ] C. Chaque angoisse est exclusivement réservée à une seule catégorie de personnes.
- [ ] D. Angoisse de morcellement et relation de type psychotique, avec déni, clivage ou projection.
- [ ] E. Une seule défense permet de conclure à une structure certaine.

Mécanismes de défense

Q71 **Quelles propositions définissent les mécanismes de défense ? (2 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. Leur présence suffit à prouver une maladie.
- [ ] B. Une même défense produit toujours le même effet chez toute personne.
- [ ] C. Ils sont tous conscients et délibérés.
- [ ] D. Leur rigidité, leur exclusivité et leurs effets doivent être considérés.
- [ ] E. Ils contribuent à protéger le Moi face aux conflits et à l'angoisse.

Q72 **Quelle proposition définit le refoulement ? (1 bonne réponse)** Intermédiaire

- [ ] A. Il maintient hors de la conscience une représentation liée à un conflit, sans supprimer son activité psychique.
- [ ] B. Il correspond obligatoirement à une simulation.
- [ ] C. Il signifie nier une réalité extérieure pourtant perçue.
- [ ] D. Il consiste à décider consciemment de penser à une difficulté demain.
- [ ] E. Il détruit matériellement toute trace mnésique.

Q73 **Après un conflit avec une autorité, une personne manifeste une colère intense envers un proche sans lien avec ce conflit. Quel mécanisme cette situation peut-elle illustrer ? (1 bonne réponse)** Intermédiaire

- [ ] A. L'introjection.
- [ ] B. L'annulation rétroactive.
- [ ] C. La sublimation.
- [ ] D. Le déplacement.
- [ ] E. La mise à l'écart volontaire.

Q74 **Un récit d'événement douloureux paraît détaché de tout affect. Quelle lecture défensive est possible, sans conclure sur ce seul signe ? (1 bonne réponse)** Intermédiaire

- [ ] A. Une preuve certaine d'absence de souffrance.
- [ ] B. Une preuve certaine de mensonge.
- [ ] C. Une formation réactionnelle nécessairement démontrée.
- [ ] D. Une isolation de la représentation et de l'affect.
- [ ] E. Un diagnostic de psychose automatiquement établi.

Q75 Intermédiaire

Une personne pense devoir effectuer un geste inverse pour effacer une pensée jugée inacceptable. Quel mécanisme est le plus directement illustré ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. L'annulation rétroactive.
- ☐ B. Le principe de réalité.
- ☐ C. L'identification.
- ☐ D. L'étayage.
- ☐ E. La condensation.

Q76 Difficile

Comment distinguer formation réactionnelle et renversement dans le contraire ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Une gentillesse occasionnelle suffit à démontrer une formation réactionnelle.
- ☐ B. Une formation réactionnelle installe une attitude opposée à une tendance conflictuelle.
- ☐ C. Les deux notions signifient simplement changer librement d'opinion.
- ☐ D. Le renversement dans le contraire peut concerner un but actif-passif ou amour-haine.
- ☐ E. Le renversement dans le contraire implique toujours un souvenir effacé.

Q77 Difficile

Quelles distinctions entre dénégation et déni sont exactes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Le déni signifie toujours tromper volontairement son interlocuteur.
- ☐ B. Le déni porte sur la reconnaissance d'une réalité extérieure perçue.
- ☐ C. La dénégation et le déni sont exactement synonymes.
- ☐ D. La dénégation permet d'énoncer un contenu tout en refusant de le reconnaître comme sien.
- ☐ E. Toute phrase contenant « non » démontre une dénégation pathologique.

Q78 Intermédiaire

Attribuer à autrui une hostilité que l'on ne reconnaît pas en soi peut illustrer quel mécanisme ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. L'introjection.
- ☐ B. La suppression volontaire d'une pensée.
- ☐ C. L'humour.
- ☐ D. La projection.
- ☐ E. La sublimation.

Q79 Difficile

Concernant le clivage, quelles propositions sont exactes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Le clivage signifie nécessairement posséder deux personnalités distinctes.
- ☐ B. Toute appréciation nuancée d'un soignant prouve un clivage.
- ☐ C. Le clivage du Moi permet la coexistence de deux attitudes incompatibles sans compromis.
- ☐ D. Un désaccord entre collègues démontre à lui seul le clivage d'un patient.
- ☐ E. Le clivage de l'objet sépare des aspects tout bons et tout mauvais.

Q80 Intermédiaire

Une agressivité dirigée initialement vers autrui se dirige contre soi. Quel mécanisme décrit ce mouvement ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Le renforcement vicariant.
- ☐ B. L'idéalisation de l'objet.
- ☐ C. L'annulation rétroactive.
- ☐ D. La métacommunication.
- ☐ E. Le retournement contre soi.

Q81 Intermédiaire

Quelles distinctions entre introjection et identification sont correctes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. L'introjection correspond à l'intériorisation psychique de l'objet ou de la relation à l'objet.
- ☐ B. L'identification transforme le sujet par assimilation d'un trait ou d'un aspect de l'autre.
- ☐ C. L'identification est toujours pathologique.
- ☐ D. Ces processus exigent toujours une imitation consciente et volontaire.
- ☐ E. L'introjection signifie attribuer son propre désir à autrui.

Q82 Difficile

Concernant l'identification à l'agresseur, quelles propositions sont exactes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Elle constitue une lecture défensive possible d'une situation menaçante.
- ☐ B. Elle rend la victime responsable de l'agression initiale.
- ☐ C. Elle peut permettre de passer d'une position subie à une position active.
- ☐ D. Elle est nécessairement une décision rationnelle explicitement choisie.
- ☐ E. Elle prouve que la personne a consenti à l'agression.

Q83 Intermédiaire

Attribuer à une personne des qualités parfaites et lui refuser toute limite peut illustrer quel mécanisme ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Une preuve suffisante de guérison.
- ☐ B. La simple observation objective d'une perfection réelle.
- ☐ C. Le refoulement démontré d'un souvenir précis.
- ☐ D. L'isolation de deux pensées.
- ☐ E. L'idéalisation.

Q84 **Lors d'une hospitalisation éprouvante, un adulte retrouve temporairement un besoin accru d'être rassuré et pris en charge. Quelles propositions sont justes ? (2 bonnes réponses)** Intermédiaire

- [ ] A. Une régression peut être envisagée.
- [ ] B. Elle impose d'infantiliser le patient.
- [ ] C. Elle prouve une perte irréversible de toutes les capacités.
- [ ] D. Elle permet de dater avec certitude un traumatisme infantile.
- [ ] E. Elle peut être transitoire et liée à la situation.

Q85 **Multiplier les activités pour éviter de ressentir une détresse peut illustrer quelle défense ? (1 bonne réponse)** Intermédiaire

- [ ] A. L'activisme.
- [ ] B. Une absence certaine d'angoisse.
- [ ] C. Toute activité professionnelle, quelle que soit sa fonction.
- [ ] D. Une dénégation nécessairement consciente.
- [ ] E. Une sublimation automatiquement établie.

Q86 **Quelles distinctions entre rationalisation et intellectualisation sont exactes ? (2 bonnes réponses)** Difficile

- [ ] A. Comprendre intellectuellement une situation suffit toujours à l'élaborer affectivement.
- [ ] B. L'intellectualisation désigne nécessairement une intelligence supérieure.
- [ ] C. L'intellectualisation privilégie l'abstraction pour tenir l'affect à distance.
- [ ] D. Toute explication rationnelle est une rationalisation défensive.
- [ ] E. La rationalisation propose une explication logique qui masque des déterminants moins acceptables.

Q87 **Concernant la sublimation, quelles propositions sont exactes ? (2 bonnes réponses)** Difficile

- [ ] A. Elle est un synonyme exact de déni.
- [ ] B. Elle signifie nécessairement suppression de toute énergie pulsionnelle.
- [ ] C. Toute activité artistique prouve à elle seule une sublimation réussie.
- [ ] D. La fiche distingue une inhibition quant au but et une dérivation vers d'autres buts.
- [ ] E. Elle transforme la satisfaction pulsionnelle vers des buts valorisés, notamment artistiques ou intellectuels.

Q88 Intermédiaire

Quelles propositions concernent l'humour et l'altruisme comme défenses ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. L'humour peut permettre de traiter une situation pénible en conservant une distance psychique.
- [ ] B. Une conduite altruiste peut avoir une fonction défensive.
- [ ] C. Tout altruisme prouve une maladie.
- [ ] D. Se moquer d'un patient est nécessairement un humour thérapeutique.
- [ ] E. L'humour garantit l'absence de souffrance.

Q89 Facile

Quelle conduite correspond à la mise à l'écart volontaire ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Attribuer à autrui un désir refusé en soi.
- [ ] B. Décider de remettre momentanément une préoccupation à plus tard afin de se concentrer sur une tâche.
- [ ] C. Perdre inconsciemment l'accès à une représentation conflictuelle.
- [ ] D. Maintenir deux attitudes incompatibles sans les intégrer.
- [ ] E. Transformer un désir hostile en sollicitude rigide.

Transfert, observation et démarche clinique

Q90 Intermédiaire

Quelles propositions définissent le transfert ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Des affects et modalités relationnelles antérieurs sont réactualisés dans une relation actuelle.
- [ ] B. Il signifie nécessairement un sentiment amoureux conscient.
- [ ] C. Il peut être positif ou négatif et avoir des effets facilitateurs ou de résistance.
- [ ] D. Il apparaît exclusivement dans une cure psychanalytique.
- [ ] E. Il prouve que toute plainte du patient est infondée.

Q91 Intermédiaire

Qu'est-ce que le contre-transfert dans la présentation du cours ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Une réaction qui doit nécessairement être agie immédiatement.
- [ ] B. Un diagnostic psychiatrique du professionnel.
- [ ] C. Une preuve automatique de faute professionnelle.
- [ ] D. L'ensemble des réactions psychiques du soignant ou du clinicien dans la relation au patient.
- [ ] E. Une garantie d'objectivité absolue du soignant.

Q92 **Un patient idéalise un membre de l'équipe et dévalorise tous les autres. Quelles attitudes sont cohérentes avec la fiche ? (2 bonnes réponses)** Difficile

- ☐ A. Entrer en compétition pour être le soignant préféré.
- ☐ B. Considérer d'emblée toutes les plaintes comme imaginaires.
- ☐ C. Examiner également les faits et les plaintes exprimées.
- ☐ D. Mettre en commun les observations et préserver un cadre d'équipe cohérent.
- ☐ E. Établir une structure définitive sur ce seul comportement.

Q93 **Quels rapprochements concernant symptôme, signe et syndrome sont exacts ? (3 bonnes réponses)** Facile

- ☐ A. Un syndrome est toujours une explication étiologique complète.
- ☐ B. Le symptôme renvoie notamment à ce qui est éprouvé et rapporté par la personne.
- ☐ C. Le syndrome désigne un regroupement de manifestations associées.
- ☐ D. Le signe renvoie à un élément observé ou objectivé lors de l'examen.
- ☐ E. L'absence de plainte exclut tout signe clinique.

Q94 **Quelle distinction entre nosographie et nosologie est correcte ? (1 bonne réponse)** Intermédiaire

- ☐ A. La nosographie traite uniquement des médicaments.
- ☐ B. Les deux dispensent de recueillir les signes.
- ☐ C. La nosographie décrit et classe les troubles ; la nosologie réfléchit à leurs entités et à leurs fondements.
- ☐ D. Un nom diagnostique résume toute l'histoire du patient.
- ☐ E. La nosologie est exclusivement une liste de symptômes sans réflexion conceptuelle.

Q95 **Quelles propositions concernent bénéfices primaire et secondaire d'un symptôme ? (2 bonnes réponses)** Difficile

- ☐ A. Le bénéfice primaire est nécessairement financier.
- ☐ B. Le bénéfice secondaire concerne des avantages liés aux conséquences du trouble.
- ☐ C. Un bénéfice secondaire démontre automatiquement une simulation.
- ☐ D. Le bénéfice primaire concerne une résolution ou une réduction interne du conflit et de l'angoisse.
- ☐ E. Reconnaître une fonction au symptôme signifie approuver la souffrance.

Q96 **Quelles précautions concernent l'évaluation psychopathologique de l'enfant ? (3 bonnes réponses)** Intermédiaire

- [ ] A. Repérer la souffrance même lorsque l'enfant paraît calme.
- [ ] B. Situer les manifestations dans le développement et le contexte relationnel.
- [ ] C. Éviter de figer trop tôt l'évolution dans une étiquette définitive.
- [ ] D. Toute agitation démontre une structure déterminée.
- [ ] E. Attendre systématiquement l'âge adulte avant toute aide.

Q97 **Quelle démarche clinique est cohérente avec la fiche ? (3 bonnes réponses)** Intermédiaire

- [ ] A. S'appuyer sur un travail pluridisciplinaire lorsque nécessaire.
- [ ] B. Remplacer l'entretien par une liste de critères isolée du contexte.
- [ ] C. Déduire tout le projet de soin du seul nom du trouble.
- [ ] D. Recueillir les manifestations, leur contexte, la demande et le retentissement avant de conclure.
- [ ] E. Intégrer les dimensions sociales, cognitives et le projet de rétablissement.

Classifications et critères diagnostiques

Q98 **Quels rapprochements entre modèles de classement sont exacts ? (3 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. Toute classification repose sur une cause unique démontrée.
- [ ] B. Une approche catégorielle détermine l'appartenance à une catégorie selon des critères.
- [ ] C. Une approche typologique décrit un profil à partir de traits essentiels.
- [ ] D. La dimensionnalité autorise un autodiagnostic certain sur un score isolé.
- [ ] E. Une approche dimensionnelle évalue des dimensions ou leur intensité.

Q99 **Quelles distinctions entre validité et fidélité sont exactes ? (3 bonnes réponses)** Difficile

- [ ] A. La fidélité interjuges concerne l'accord entre différents évaluateurs.
- [ ] B. La validité interne exige qu'aucune comorbidité n'existe.
- [ ] C. La validité concerne la pertinence de ce qui est mesuré ou classé.
- [ ] D. Une classification fidèle est nécessairement valide.
- [ ] E. Une stabilité temporelle s'interprète en tenant compte de la stabilité clinique réelle.

Q100 **Quelles propositions décrivent sensibilité et spécificité ? (2 bonnes réponses)** Intermédiaire

- [ ] A. Une bonne spécificité limite les faux positifs.
- [ ] B. Ces qualités dispensent de considérer l'utilité clinique.
- [ ] C. Une bonne sensibilité limite les faux négatifs.
- [ ] D. La sensibilité est l'empathie de l'examinateur.
- [ ] E. Un faux positif correspond à un trouble réel qui n'a pas été repéré.

Q101 **Quel seuil symptomatique est présenté pour l'épisode dépressif caractérisé ? (2 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. Une tristesse de quelques minutes suffit toujours.
- [ ] B. Au moins l'un des symptômes est l'humeur dépressive ou la perte d'intérêt ou de plaisir.
- [ ] C. Les symptômes peuvent être répartis sur des années sans coexistence sur la période.
- [ ] D. Les neuf symptômes sont tous obligatoires.
- [ ] E. Au moins cinq symptômes parmi neuf pendant une même période d'au moins deux semaines.

Q102 **Quelles manifestations figurent parmi les neuf domaines symptomatiques de l'épisode dépressif caractérisé ? (3 bonnes réponses)** Intermédiaire

- [ ] A. Les troubles du sommeil et la fatigue ou perte d'énergie.
- [ ] B. Une euphorie expansive obligatoire.
- [ ] C. La diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer, ou l'indécision.
- [ ] D. Une hallucination obligatoire pour tout épisode.
- [ ] E. La dévalorisation ou culpabilité excessive ou inappropriée.

Q103 **Concernant les critères somatiques et psychomoteurs de l'épisode dépressif caractérisé, quelles propositions sont exactes ? (2 bonnes réponses)** Difficile

- [ ] A. Une prise de poids exclut nécessairement l'épisode.
- [ ] B. L'insomnie est l'unique trouble du sommeil possible.
- [ ] C. Une modification significative de poids ou de l'appétit peut être retenue dans les conditions du critère.
- [ ] D. L'agitation ou le ralentissement psychomoteur doit être observable par autrui.
- [ ] E. Toute fatigue isolée confirme l'épisode.

Q104 Difficile

Quelles précisions concernent les pensées de mort et le retentissement ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Une pensée suicidaire est toujours anodine si la personne paraît calme.
- [ ] B. Un fonctionnement antérieur différent n'a aucune importance.
- [ ] C. Les pensées de mort récurrentes ne se réduisent pas à la seule peur de mourir.
- [ ] D. L'absence de projet suicidaire précis exclut toute idée suicidaire.
- [ ] E. Une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement est requise.

Q105 Difficile

Quelles précautions diagnostiques sont exactes ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Distinguer les critères d'un épisode dépressif de ceux d'un trouble dépressif unipolaire.
- [ ] B. Un antécédent maniaque ou hypomaniaque doit être recherché pour le classement du trouble.
- [ ] C. Rechercher une substance ou une autre affection médicale pouvant expliquer l'épisode.
- [ ] D. Un antécédent maniaque rend impossible tout épisode dépressif ultérieur.
- [ ] E. Un contexte de deuil exclut toujours un épisode dépressif.

Q106 Intermédiaire

Quelles caractéristiques du DSM sont présentées dans la fiche ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Il poursuit une intention descriptive et athéorique quant aux causes.
- [ ] B. Il constitue une classification de toutes les maladies physiques et mentales par l'OMS.
- [ ] C. Il est élaboré par l'Association américaine de psychiatrie.
- [ ] D. Il fournit à lui seul une explication complète de chaque personne.
- [ ] E. Des spécifications dimensionnelles peuvent compléter les catégories.

Q107 Intermédiaire

Comment interpréter sévérité, rémission et diagnostic provisoire ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. La mention non spécifiée signifie que la personne n'éprouve aucune souffrance.
- [ ] B. Une rémission ne signifie pas nécessairement guérison définitive.
- [ ] C. Un diagnostic provisoire peut refléter des informations encore insuffisantes.
- [ ] D. Une rémission impose que tout traitement soit déjà arrêté.
- [ ] E. La sévérité tient notamment au nombre, à l'intensité et au retentissement des symptômes.

Q108 Intermédiaire

Concernant le diagnostic principal, le motif de consultation et les diagnostics associés, quelles propositions sont exactes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Le diagnostic principal remplace le recueil des besoins sociaux.
- [ ] B. Le premier mot prononcé par le patient fixe automatiquement le diagnostic principal.
- [ ] C. Plusieurs troubles peuvent être associés chez une même personne.
- [ ] D. Le motif exprimé et le diagnostic principal ne sont pas nécessairement identiques.
- [ ] E. Un diagnostic associé est nécessairement une erreur de classement.

Q109 **Quelles distinctions entre CIM et CFTMEA sont exactes ? (3 bonnes réponses)** Intermédiaire

- [ ] A. La CIM et le DSM ont exactement le même organisme auteur.
- [ ] B. La CFTMEA est exclusivement un inventaire des maladies cardiovasculaires.
- [ ] C. La CIM est portée par l'OMS et concerne l'ensemble des maladies.
- [ ] D. Une correspondance de codage ne signifie pas identité complète des modèles.
- [ ] E. La CFTMEA concerne les troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent.

Repères historiques et raisonnement transversal

Q110 **Dans la nosographie freudienne historique présentée, quels rapprochements sont corrects ? (2 bonnes réponses)** Difficile

- [ ] A. Ces regroupements sont identiques à toutes les catégories DSM contemporaines.
- [ ] B. Une ancienne étiquette dispense de décrire les manifestations présentes.
- [ ] C. Le terme « actuelle » signifie simplement « à la mode aujourd'hui ».
- [ ] D. Névroses actuelles : notamment névrose d'angoisse, neurasthénie et hypocondrie.
- [ ] E. Névroses de transfert : notamment hystérie, névrose obsessionnelle et phobique.

Q111 **Quels repères concernant les psychoses dans la classification française historique sont exacts ? (3 bonnes réponses)** Intermédiaire

- [ ] A. La schizophrénie signifie nécessairement deux personnalités qui alternent.
- [ ] B. Une bouffée délirante aiguë évolue obligatoirement de la même façon chez tous.
- [ ] C. Paranoïa, psychose hallucinatoire chronique et paraphrénie sont distinguées parmi les formes chroniques non dissociatives.
- [ ] D. La schizophrénie appartient au groupe historique des psychoses chroniques dissociatives.
- [ ] E. La bouffée délirante aiguë appartient aux formes aiguës.

Q112 **Quelle distinction entre barrage et fading est correcte ? (1 bonne réponse)** Intermédiaire

- [ ] A. Le fading désigne une accélération progressive sans interruption.
- [ ] B. Le barrage est une interruption brusque du cours de la pensée ou du discours ; le fading correspond à un effacement progressif.
- [ ] C. Un seul silence permet de confirmer une schizophrénie.
- [ ] D. Les deux termes désignent une hausse mesurée de la température.
- [ ] E. Le barrage est toujours une décision volontaire de se taire.

Q113 **Quelles propositions illustrent une lecture transversale cohérente avec la fiche ? (3 bonnes réponses)**

Difficile

- [ ] A. Un état mélancolique peut être grave et impose de considérer la souffrance et le risque.
- [ ] B. Un modèle en réseau s'intéresse aux relations entre manifestations.
- [ ] C. Un symptôme possède nécessairement une cause unique indépendante de tous les autres.
- [ ] D. Le nom d'un modèle autorise à conclure sans évaluation du patient.
- [ ] E. Un même processus peut intervenir dans plusieurs catégories diagnostiques.

Corrigés argumentés

Fondements, normalité et causalité

Q01 — Réponses : A, B. A — Vrai. La clinique s'intéresse au vécu particulier de chaque sujet. B — Vrai. La psychopathologie étudie les manifestations et leurs mécanismes. C — Faux. Une différence ou une rareté ne suffit pas à définir une pathologie. D — Faux. Son champ ne se réduit pas à une évaluation cognitive. E — Faux. Le cours articule plusieurs niveaux de causalité.

Q02 — Réponses : A, B, E. A — Vrai. Il présente la psychopathologie comme une science de cette souffrance. B — Vrai. La définition porte sur la souffrance quelle que soit son origine. C — Faux. La déviance ne résume pas les troubles ni la souffrance. D — Faux. L'évolution fait partie des dimensions étudiées. E — Vrai. Ces quatre dimensions sont explicitement associées à sa définition.

Q03 — Réponses : A, C, D. A — Vrai. Cette lecture ne se limite pas à la cause de la souffrance. B — Faux. L'axe décrit une lecture globale de l'expérience vécue. C — Vrai. La clinique considère ce qui est propre à ce sujet. D — Vrai. Cet axe examine les aspects pathologiques de la vie psychologique. E — Faux. La singularité est précisément son point d'attention.

Q04 — Réponses : D. A — Faux. Plusieurs paramètres cliniques et contextuels doivent être croisés. B — Faux. Une différence d'expression n'est pas un critère suffisant. C — Faux. Le contexte de deuil ne dispense pas d'évaluer l'évolution et le retentissement. D — Vrai. Des pleurs isolés ne suffisent pas à identifier un trouble dépressif. E — Faux. L'émotion seule ne fournit pas les critères d'un tel épisode.

Q05 — Réponses : A, E. A — Vrai. L'apparence de calme ne permet pas de banaliser une parole de mort. B — Faux. La fréquence ne neutralise pas son importance clinique. C — Faux. Le repérage ne doit pas attendre un passage à l'acte. D — Faux. L'expression visible ne mesure pas à elle seule la souffrance. E — Vrai. La sécurité et le danger font partie des paramètres à apprécier.

Q06 — Réponses : A, B, D. A — Vrai. Une appréciation isolée de l'intensité serait insuffisante. B — Vrai. Fonctionnement et sécurité figurent dans les repères du cours. C — Faux. Les valeurs du professionnel ne constituent pas un diagnostic. D — Vrai. Le contexte culturel éclaire le sens et l'adaptation des expériences. E — Faux. Une originalité n'est pas nécessairement une pathologie.

Corrigés argumentés — suite

Q07 — Réponses : A, B. A — Vrai. La personne peut méconnaître son trouble. B — Vrai. Elles complètent le vécu rapporté par la personne. C — Faux. Elle désigne une méconnaissance, pas une tromperie volontaire. D — Faux. Il doit être intégré à une évaluation, sans se substituer à elle. E — Faux. Méconnaissance du trouble et absence de trouble ne sont pas équivalentes.

Q08 — Réponses : A, C. A — Vrai. La signification de l'écart dépend des normes et du contexte. B — Faux. L'adaptation et les difficultés concrètes restent à examiner. C — Vrai. Le cours insiste sur ce travail de contextualisation. D — Faux. La rareté est un repère possible, pas une preuve suffisante. E — Faux. Les normes évoluent selon les sociétés et les périodes.

Q09 — Réponses : A. A — Vrai. Sujets, observateurs, culture, lieu et époque peuvent modifier son expression. B — Faux. Elle concerne les formes d'expression, pas une causalité universelle. C — Faux. Cette proposition nie précisément les variations étudiées. D — Faux. La pathoplasticité n'est pas une simulation. E — Faux. Un contexte peut modifier un tableau sans en assurer la disparition.

Q10 — Réponses : B, C, D. A — Faux. Les cadres de lecture influencent l'appréhension des manifestations. B — Vrai. Les études scientifiques et longitudinales affinent les trajectoires connues. C — Vrai. C'est l'argument épistémologique. D — Vrai. C'est l'argument socioculturel. E — Faux. Le cours décrit aussi un argument temporel ou diachronique.

Q11 — Réponses : B, D, E. A — Faux. Une origine psychologique supposée ne signifie pas une souffrance fictive. B — Vrai. Elle situe les manifestations dans un fonctionnement psychologique. C — Faux. La dimension génétique relève de la lecture organogénétique. D — Vrai. Le contexte social contribue sans déterminer seul un devenir individuel. E — Vrai. Elle examine notamment les mécanismes structurels, fonctionnels ou génétiques.

Q12 — Réponses : A, B. A — Vrai. Elle travaille leurs interactions plutôt qu'une opposition obligatoire. B — Vrai. L'oral utilise notamment l'exemple du placebo pour éviter cette dichotomie. C — Faux. Ces dimensions peuvent interagir. D — Faux. L'absence de lésion retrouvée ne démontre pas à elle seule une cause. E — Faux. Le modèle est multifactoriel.

Corrigés argumentés — suite

Approches thérapeutiques et apprentissages

Q13 — Réponses : C, D, E. A — Faux. Elle articule justement plusieurs approches. B — Faux. Elle étudie d'abord les interactions et la communication dans les systèmes. C — Vrai. La personne constitue son point de départ privilégié. D — Vrai. Elle prend en compte les influences réciproques. E — Vrai. Elle privilégie les facteurs contextuels et situationnels.

Q14 — Réponses : B, E. A — Faux. Une lecture biologique ne suppose pas une tromperie. B — Vrai. Le cours maintient une place pour le psychique et la relation. C — Faux. Ce n'est pas le facteur privilégié de ce modèle. D — Faux. Les dimensions peuvent être articulées dans une approche globale. E — Vrai. La lecture biologique s'intéresse aux facteurs organiques.

Q15 — Réponses : A. A — Vrai. Le modèle répondant repose sur l'association de stimuli. B — Faux. Le refoulement appartient à une autre grille théorique. C — Faux. Cette proposition renvoie au modèle systémique. D — Faux. Il s'agit de l'apprentissage vicariant. E — Faux. La place des conséquences caractérise plutôt le conditionnement opérant.

Q16 — Réponses : C, E. A — Faux. Le scénario décrit un apprentissage, pas un refoulement. B — Faux. La définition fonctionnelle ne se réduit pas à une récompense agréable. C — Vrai. Un effet qui augmente la répétition de la conduite a une fonction de renforcement. D — Faux. L'observation d'un modèle n'est pas décrite ici. E — Vrai. Il relie le comportement à ses conséquences dans l'environnement.

Q17 — Réponses : B, D. A — Faux. Le modèle et ses conséquences appartiennent justement à l'environnement. B — Vrai. Il repose sur l'observation d'un modèle et de ses conséquences. C — Faux. Les cadres cognitifs et psychanalytiques ne sont pas équivalents. D — Vrai. L'observation peut suffire à modifier ses conduites. E — Faux. Le scénario décrit une acquisition par l'expérience d'autrui.

Q18 — Réponses : C, D, E. A — Faux. Cette lecture n'est pas sa méthode propre. B — Faux. L'approche présentée met l'accent sur les acquisitions. C — Vrai. Les interactions avec l'environnement peuvent entretenir le symptôme. D — Vrai. L'histoire des apprentissages est un point d'attention. E — Vrai. Le travail porte sur des apprentissages et conduites plus adaptés.

Corrigés argumentés — suite

Q19 — Réponses : A, B, E. A — Vrai. La causalité circulaire examine ces influences réciproques. B — Vrai. Le thérapeute aide à reconnaître règles et possibilités du système. C — Faux. Le modèle ne justifie pas une accusation causale automatique. D — Faux. La notion ne désigne pas une culpabilité délibérée. E — Vrai. Le terme situe le symptôme dans un ensemble d'interactions.

Q20 — Réponses : A. A — Vrai. On explicite des règles, implicites ou malentendus de l'échange. B — Faux. La manière de communiquer est précisément interrogée. C — Faux. Ce n'est pas une opération de communication. D — Faux. La démarche cherche au contraire à les rendre discutables. E — Faux. Cela ne définit pas la métacommunication.

Q21 — Réponses : C, E. A — Faux. Le modèle valorise la mobilisation des ressources du système. B — Faux. Elle aide à comprendre et transformer la communication. C — Vrai. L'oral donne des exemples d'entretiens séparés ou sans le patient. D — Faux. Le changement peut être ciblé et progressif. E — Vrai. Le cours distingue ce niveau d'un changement des règles du système.

Q22 — Réponses : A, B, E. A — Vrai. Elles intègrent la démarche comportementale. B — Vrai. Le cours décrit aussi des exercices émotionnels. C — Faux. Le suivi des progrès aide à adapter le travail. D — Faux. Les facteurs subjectifs et cognitifs sont également examinés. E — Vrai. La manière d'interpréter participe à la souffrance et à son maintien.

Q23 — Réponses : A, C. A — Vrai. Les schémas organisent les informations et les attentes. B — Faux. Ce comportement ne suffit pas à une telle conclusion. C — Vrai. La lecture articule pensées, émotions et comportements. D — Faux. La formulation ne démontre pas un contenu psychanalytique particulier. E — Faux. Une orientation du traitement de l'information peut échapper à la conscience.

Q24 — Réponses : A, B, D. A — Vrai. Ce versant est explicitement présent dans la fiche vérifiée. B — Vrai. La démarche comporte une collaboration sur les objectifs. C — Faux. Elles illustrent la progressivité, sans règle applicable à tous. D — Vrai. Le suivi oriente la poursuite ou la fin du travail. E — Faux. La durée ne se transforme pas en quota universel.

Corrigés argumentés — suite

Psychanalyse, histoire et formations de l'inconscient

Q25 — Réponses : A, C, E. A — Vrai. La psychanalyse comporte une dimension thérapeutique. B — Faux. Cela ne correspond pas à sa définition. C — Vrai. Il s'agit d'une de ses dimensions constitutives. D — Faux. Les modèles psychiques ne sont pas des localisations anatomiques. E — Vrai. Le cours relie théorie, investigation et méthode.

Q26 — Réponses : A, D. A — Vrai. Il ne se superpose pas nécessairement au découpage anatomique. B — Faux. Un symptôme moteur nécessite une évaluation de ses causes. C — Faux. L'absence d'anomalie ne suffit pas à conclure à une cause psychique. D — Vrai. L'absence de lésion explicative n'implique pas une tromperie. E — Faux. Cette apparence ne prouve ni simulation ni volontarisme.

Q27 — Réponses : A, B. A — Vrai. Ils ne constituent pas une cinquième période équivalente aux quatre autres. B — Vrai. Elle comporte des attitudes corporelles spectaculaires. C — Faux. Elle clôt la succession décrite. D — Faux. Elle décrit historiquement une imitation de la crise épileptique. E — Faux. La première période est dite épileptique ou épileptoïde.

Q28 — Réponses : B, C. A — Faux. Un récit fondateur ne fournit pas une garantie thérapeutique universelle. B — Vrai. La méthode historique vise la libération d'affects restés liés à l'événement. C — Vrai. L'expression désigne l'importance thérapeutique de la mise en récit. D — Faux. Il s'agit d'un état de conscience modifié dans le récit historique. E — Faux. Elle est associée à la libération émotionnelle, pas à une interdiction de récit.

Q29 — Réponses : C, D, E. A — Faux. Réalité psychique et fait extérieur ne sont pas identiques. B — Faux. Les deux dimensions peuvent être présentes. C — Vrai. Elle donne une place aux conflits internes. D — Vrai. Le cours précise qu'elle n'annule pas la réalité des traumatismes. E — Vrai. Le mot historique ne signifie pas un consentement de l'enfant.

Q30 — Réponses : D, E. A — Faux. Le modèle décrit aussi des phénomènes de la vie quotidienne. B — Faux. Les processus décrits peuvent être inconscients. C — Faux. Il s'agit d'un concept de fonctionnement psychique. D — Vrai. Le compromis ne constitue pas une satisfaction directe et simple. E — Vrai. La notion articule notamment désir et défense.

Corrigés argumentés — suite

Q31 — Réponses : D. A — Faux. L'interprétation dépend des associations du sujet. B — Faux. Le cours récuse une clé symbolique valable indépendamment du rêveur. C — Faux. Les deux termes sont ici inversés. D — Vrai. La distinction relie le récit à ce qui est exploré par les associations. E — Faux. Il désigne des pensées et désirs dans le modèle psychanalytique.

Q32 — Réponses : A, C, E. A — Vrai. Le cours insiste sur la représentation imagée dans le rêve. B — Faux. Elle contribue au contraire à une certaine cohérence. C — Vrai. L'accent affectif change d'objet par association. D — Faux. Un élément de la journée peut fournir du matériau onirique. E — Vrai. Un personnage peut combiner plusieurs personnes ou chaînes associatives.

Q33 — Réponses : B, E. A — Faux. La fonction décrite peut échapper à la conscience. B — Vrai. L'apparition d'une autre manifestation ne peut être postulée systématiquement. C — Faux. La possibilité d'une migration ne disqualifie pas le traitement. D — Faux. Comprendre une fonction ne justifie pas de s'opposer aux soins nécessaires. E — Vrai. Le cours invite à associer soulagement et compréhension du fonctionnement.

Q34 — Réponses : D, E. A — Faux. Son sens théorique ne se réduit pas à une intention consciente. B — Faux. Une erreur isolée ne suffit pas. C — Faux. Une interprétation automatique serait abusive. D — Vrai. Le modèle psychanalytique peut en explorer le sens à partir des associations. E — Vrai. Il n'est pas automatiquement une maladie.

Q35 — Réponses : B, D. A — Faux. Elle s'oppose à cette sélection imposée du contenu. B — Vrai. Elle vise à explorer des liens qui échappent au récit organisé. C — Faux. Elle doit être située dans les associations et l'histoire du sujet. D — Vrai. Elle ne se réduit pas à de la mauvaise volonté consciente. E — Faux. Son fonctionnement peut être inconscient.

Pulsions et appareil psychique

Q36 — Réponses : B, C. A — Faux. Ces fonctions ne constituent pas les quatre caractères de la pulsion. B — Vrai. La source est corporelle ; la poussée constitue la force de l'exigence pulsionnelle. C — Vrai. Le but est la satisfaction ; l'objet permet de l'atteindre et peut varier. D — Faux. Ces termes relèvent de l'évaluation clinique. E — Faux. La pulsion ne se définit pas par ces deux facultés.

Corrigés argumentés — suite

Q37 — Réponses : D. A — Faux. Un phénomène isolé ne détermine pas une structure ou un diagnostic. B — Faux. Le destin de la pulsion peut être transformé ou défendu. C — Faux. Son objet est variable ; elle ne se réduit pas à l'instinct. D — Vrai. La pulsion est un concept métapsychologique ; l'impulsion concerne une tendance immédiate à l'acte. E — Faux. Il renvoie à un comportement inné, organisé et propre à l'espèce.

Q38 — Réponses : B, C, E. A — Faux. Elle ne se limite ni à une image ni à la conscience. B — Vrai. Il peut connaître un destin différent de celui de la représentation. C — Vrai. Cette distinction aide à penser les systèmes psychiques et leur liaison. D — Faux. Les mécanismes défensifs peuvent les dissocier. E — Vrai. Elle constitue une modalité d'inscription psychique.

Q39 — Réponses : A. A — Vrai. Les lieux de la topique sont des lieux psychiques, sans correspondance anatomique directe. B — Faux. Un modèle explicatif ne remplace pas l'évaluation clinique. C — Faux. La topique n'est pas une carte anatomique. D — Faux. La notion n'est pas cette structure physiologique. E — Faux. Ce concept ne définit pas un score intellectuel.

Q40 — Réponses : A, B, D. A — Vrai. Ils sont accessibles sans franchir le refoulement au sens de l'inconscient refoulé. B — Vrai. La réception consciente se distingue de l'inscription des traces mnésiques. C — Faux. Un contenu préconscient peut simplement être hors du champ actuel de la conscience. D — Vrai. Il est associé à l'énergie libre, à la condensation et au déplacement. E — Faux. La première topique les différencie.

Q41 — Réponses : B, C. A — Faux. L'atemporalité permet au contraire sa persistance. B — Vrai. Les contenus inconscients ne vieillissent pas selon cette organisation. C — Vrai. La logique inconsciente ne respecte pas le principe conscient de non-contradiction. D — Faux. Cette vérification n'organise pas les processus primaires. E — Faux. Ils ne caractérisent pas ce fonctionnement.

Q42 — Réponses : A. A — Vrai. Ils remplissent des fonctions différentes dans le modèle. B — Faux. Le débordement des capacités de liaison est une dimension du traumatisme psychique. C — Faux. Il s'agit ici d'une fonction psychique. D — Faux. Leurs fonctions ne se confondent pas. E — Faux. Il limite les excitations sans abolir la vie affective.

Q43 — Réponses : B, C, E. A — Faux. Une partie de son fonctionnement défensif est inconsciente. B — Vrai. Il exerce notamment une fonction critique. C — Vrai. Il participe également à l'identité et aux défenses. D — Faux. Cette fonction ne définit pas le Ça. E — Vrai. Il ne se règle pas sur les exigences morales.

Corrigés argumentés — suite

Q44 — Réponses : C, D. A — Faux. La seconde topique complète la modélisation. B — Faux. Cette correspondance est inexacte. C — Vrai. La seconde topique ne se superpose pas terme à terme à la première. D — Vrai. La culpabilité se rapporte notamment à la transgression ; la honte à l'écart à un idéal. E — Faux. Il s'agit d'une instance psychique intériorisée.

Q45 — Réponses : C. A — Faux. L'hypothèse porte précisément sur une difficulté d'élaboration. B — Faux. La fiche refuse cette équivalence. C — Vrai. Elle propose une compréhension de certaines situations, sans devenir un diagnostic universel. D — Faux. L'interprétation reste contextualisée. E — Faux. Le préconscient est un système théorique, non un organe.

Économie psychique et conflits

Q46 — Réponses : B, E. A — Faux. Ils constituent des perspectives complémentaires. B — Vrai. Il étudie les mouvements de l'énergie psychique dans le modèle. C — Faux. Il désigne les rapports de forces psychiques. D — Faux. Le mot a ici un sens métapsychologique. E — Vrai. Il permet de penser les compromis et les défenses.

Q47 — Réponses : A, D, E. A — Vrai. Il tient compte des contraintes du monde extérieur. B — Faux. Il aménage les voies de satisfaction. C — Faux. Cette capacité se construit progressivement, dans une relation suffisamment fiable. D — Vrai. Il participe au point de vue économique du modèle présenté. E — Vrai. Il oriente vers une recherche de satisfaction.

Q48 — Réponses : B. A — Faux. Un investissement libidinal peut participer à des conflits. B — Vrai. Le terme ne se réduit pas à la fréquence des rapports sexuels. C — Faux. Les investissements peuvent être inconscients. D — Faux. La notion n'est pas équivalente à l'alimentation. E — Faux. Ce nombre ne définit pas ce concept.

Q49 — Réponses : A, E. A — Vrai. Ils distinguent des directions d'investissement libidinal. B — Faux. Ils se caractérisent notamment par condensation et déplacement. C — Faux. L'objet psychanalytique peut être une personne ou sa représentation. D — Faux. La compulsion de répétition peut reproduire du déplaisir. E — Vrai. Ils permettent notamment de différer l'action.

Corrigés argumentés — suite

Q50 — Réponses : A, B, C. A — Vrai. Elle évite d'imaginer une manifestation toujours pure de l'une des deux tendances. B — Vrai. Il s'agit du premier dualisme présenté. C — Vrai. Elle constitue une construction théorique, sans mesure directe d'une pulsion isolée. D — Faux. La conduite clinique ne se déduit pas mécaniquement de ce concept. E — Faux. Ce sont des modèles psychanalytiques.

Q51 — Réponses : B. A — Faux. Le modèle distingue besoin et satisfaction pulsionnelle. B — Vrai. La satisfaction peut se détacher du seul besoin nutritionnel. C — Faux. Ce comportement ne suffit pas à établir une pathologie. D — Faux. Ce mécanisme ne décrit pas la situation. E — Faux. L'exemple illustre précisément une satisfaction corporelle.

Q52 — Réponses : B, C, D. A — Faux. Le modèle distingue la répétition de l'intention consciente. B — Vrai. Elle ne se limite pas au deuil. C — Vrai. Elle ne s'explique pas toujours par la seule recherche de plaisir immédiat. D — Vrai. Conserver un lien intérieur à l'objet perdu peut y participer. E — Faux. Le lien intérieur peut se transformer sans disparition des traces.

Développement psychoaffectif

Q53 — Réponses : B, E. A — Faux. Des modalités antérieures peuvent persister. B — Vrai. La fixation concerne un maintien d'investissement ; la régression un retour à un fonctionnement antérieur. C — Faux. Le raisonnement causal ne se réduit pas à ce repérage. D — Faux. Une lecture globale et contextualisée reste nécessaire. E — Vrai. La succession ne décrit pas une mécanique uniforme.

Q54 — Réponses : C, D. A — Faux. Les sous-phases ne sont pas réductibles à une relation uniformément paisible. B — Faux. Elle comprend une dimension pulsionnelle distincte. C — Vrai. Elle dépasse la seule bouche envisagée comme organe alimentaire. D — Vrai. Elle permet de penser le rapport au dedans et à l'objet. E — Faux. Le modèle décrit notamment des objets partiels.

Q55 — Réponses : A, B, C. A — Vrai. Elles mettent en jeu maîtrise et rapport aux matières fécales. B — Vrai. Leur valeur relationnelle dépasse leur statut de déchet. C — Vrai. Ces enjeux participent à cette organisation. D — Faux. La maîtrise constitue au contraire un enjeu important. E — Faux. Le repère présenté se situe autour de deux à trois ans.

Corrigés argumentés — suite

Q56 — Réponses : D, E. A — Faux. Le contexte et les caractéristiques du comportement doivent être examinés. B — Faux. Comprendre le développement n'abolit pas les limites protectrices. C — Faux. Il s'agit d'une construction théorique historique à contextualiser. D — Vrai. Le vocabulaire phallique ne renvoie pas uniquement à l'anatomie. E — Vrai. Il ne se confond pas avec l'organisation génitale pubertaire.

Q57 — Réponses : A, B, E. A — Vrai. La place du tiers est essentielle. B — Vrai. Il ne se réduit pas à une seule direction de désir et de rivalité. C — Faux. La triangularité est un élément central. D — Faux. Un modèle théorique ne reconstitue pas automatiquement les événements vécus. E — Vrai. Le renoncement à avoir l'objet peut s'accompagner du désir d'être comme une figure parentale.

Q58 — Réponses : B. A — Faux. Le développement se poursuit. B — Vrai. Elle ne constitue pas l'apparition d'une nouvelle zone érogène dominante. C — Faux. Le repère donné se situe vers six-sept ans jusqu'à la puberté. D — Faux. Ce n'est pas sa définition. E — Faux. Les conflits ne sont pas abolis.

Q59 — Réponses : B, C. A — Faux. Un remaniement développemental n'est pas à lui seul pathologique. B — Vrai. Ils participent au travail psychique adolescent. C — Vrai. Elle ne se réduit pas à des transformations corporelles. D — Faux. Les expériences antérieures restent impliquées. E — Faux. Elles peuvent être remaniées.

Q60 — Réponses : C, E. A — Faux. Le concept a aussi une place dans le développement et le fonctionnement ordinaires. B — Faux. Il est décrit comme une modalité de satisfaction pulsionnelle. C — Vrai. Il ne suppose pas encore le Moi unifié du narcissisme. D — Faux. L'objet peut être une personne. E — Vrai. Il se distingue de l'autoérotisme et de l'investissement d'un objet extérieur.

Q61 — Réponses : B, E. A — Faux. Ils décrivent des organisations psychiques théoriques. B — Vrai. Il est distingué du temps sadique-oral. C — Faux. Le signe doit être replacé dans le développement et le contexte. D — Faux. Les enjeux ne s'arrêtent pas de manière absolue. E — Vrai. La destruction est ici décrite sur un plan fantasmatique.

Q62 — Réponses : A, E. A — Vrai. Il s'agit de constructions infantiles, à situer dans le cadre du cours. B — Faux. Une représentation ne prouve pas un fait matériel précis. C — Faux. Une théorie infantile isolée ne suffit pas au diagnostic. D — Faux. Comprendre sa représentation ne signifie pas la présenter comme vraie. E — Vrai. Elles ne sont pas des connaissances anatomiques exactes.

Corrigés argumentés — suite

Q63 — Réponses : A, E. A — Vrai. L'accompagnement ne se résume pas à une réponse corporelle. B — Faux. Une évaluation spécialisée et individualisée est nécessaire. C — Faux. Le moment et la demande doivent être respectés. D — Faux. Les besoins psychiques et relationnels restent à considérer. E — Vrai. La fiche évoque notamment l'évaluation spécialisée des possibilités de reconstruction.

Angoisses et organisations psychiques

Q64 — Réponses : C. A — Faux. Elle peut s'accompagner de manifestations somatiques. B — Faux. Elle ne se définit pas comme un choix. C — Vrai. Cette distinction aide à décrire le vécu sans suffire au diagnostic. D — Faux. Elle se rencontre dans des fonctionnements variés. E — Faux. La souffrance psychique peut être réelle sans danger extérieur objectivable.

Q65 — Réponses : B, C, D. A — Faux. L'objet est ici entendu au sens relationnel et psychanalytique. B — Vrai. Elle ne se limite pas à une mutilation génitale réelle. C — Vrai. Elle peut comporter des vécus d'anéantissement ou de chute sans fin. D — Vrai. La perte peut être réelle ou fantasmée. E — Faux. Le contexte, notamment les situations extrêmes, doit être pris en compte.

Q66 — Réponses : A, C. A — Vrai. Le destin de l'affect est distingué de celui de la représentation refoulée. B — Faux. Aucune des deux ne la définit ainsi. C — Vrai. Le rapport causal avec le refoulement est remanié. D — Faux. Leurs destins sont distingués. E — Faux. Cette fonction y est centrale.

Q67 — Réponses : A. A — Vrai. La métaphore illustre des modalités organisées de fonctionnement. B — Faux. Il s'agit d'une image théorique. C — Faux. L'analyse clinique demeure nécessaire. D — Faux. Une structure ne s'infère pas d'un signe isolé. E — Faux. Une organisation peut rester compensée.

Q68 — Réponses : C, E. A — Faux. Elle peut être source de symptômes invalidants. B — Faux. Les logiques de classement diffèrent. C — Vrai. Elle ne se réduit pas à une simple excentricité. D — Faux. Les défenses s'interprètent dans une organisation d'ensemble. E — Vrai. Cette description n'exclut pas une souffrance importante.

Q69 — Réponses : B, E. A — Faux. Un seul vécu ne suffit pas à établir l'organisation. B — Vrai. L'objet soutient l'équilibre psychique. C — Faux. Cette équivalence est incorrecte. D — Faux. Les modèles ne sont pas superposables terme à terme. E — Vrai. Ils ne constituent pas une troisième structure fixée au même titre dans ce modèle.

Corrigés argumentés — suite

Q70 — Réponses : A, B, D. A — Vrai. L'appui sur l'objet externe est particulièrement décrit dans ce modèle. B — Vrai. C'est une affinité théorique présentée, non une preuve isolée. C — Faux. Le tableau ne doit pas être transformé en règle absolue. D — Vrai. L'intégrité et l'unité sont des enjeux centraux de ce rapprochement. E — Faux. La compréhension exige une organisation d'ensemble.

Mécanismes de défense

Q71 — Réponses : D, E. A — Faux. Ils participent aussi au fonctionnement ordinaire. B — Faux. Son sens dépend du fonctionnement et du contexte. C — Faux. La plupart sont décrits comme inconscients. D — Vrai. Une défense ne se juge pas uniquement sur son nom. E — Vrai. Ils remplissent une fonction dans l'équilibre psychique.

Q72 — Réponses : A. A — Vrai. Le refoulé peut continuer à produire des effets et des formations de compromis. B — Faux. La simulation ne définit pas un processus inconscient. C — Faux. Cette définition concerne plutôt le déni. D — Faux. Cette décision relève de la mise à l'écart volontaire. E — Faux. Le maintien hors de la conscience n'est pas une destruction.

Q73 — Réponses : D. A — Faux. La situation ne décrit pas l'intériorisation d'un objet. B — Faux. Aucun acte opposé destiné à effacer le premier n'est décrit. C — Faux. Le déplacement de colère ne suffit pas à décrire une transformation vers une activité valorisée. D — Vrai. L'intensité affective se déplace d'une représentation ou d'un objet vers un autre moins menaçant. E — Faux. La colère n'est pas ici simplement remise à plus tard par décision.

Q74 — Réponses : D. A — Faux. L'absence d'expression affective ne prouve pas l'absence de souffrance. B — Faux. Cette observation isolée ne permet pas une telle conclusion. C — Faux. Aucun trait opposé au désir n'est suffisamment décrit. D — Vrai. La représentation demeure accessible tandis que son lien affectif semble coupé. E — Faux. Une observation isolée ne détermine pas le diagnostic.

Q75 — Réponses : A. A — Vrai. Une action ou une pensée cherche symboliquement à supprimer la précédente, selon une logique de toute-puissance de la pensée. B — Faux. Un geste ne supprime pas réellement le fait d'avoir eu une pensée. C — Faux. Elle suppose l'assimilation d'un trait ou d'un aspect d'un autre. D — Faux. Il concerne l'appui de la sexualité infantile sur l'autoconservation. E — Faux. Aucune réunion de plusieurs chaînes de représentations dans un élément n'est décrite.

Corrigés argumentés — suite

Q76 — Réponses : B, D. A — Faux. Il faut examiner sa fonction dans l'ensemble du fonctionnement. B — Vrai. Son caractère rigide peut participer à la fonction défensive. C — Faux. Leur sens théorique dépasse une variation d'avis. D — Vrai. Il porte sur le destin de la tendance pulsionnelle. E — Faux. Ce n'est pas sa définition.

Q77 — Réponses : B, D. A — Faux. Il ne se réduit pas à un mensonge conscient. B — Vrai. Il ne se confond pas avec la seule négation grammaticale. C — Faux. Ils se distinguent dans le modèle présenté. D — Vrai. La formulation négative peut laisser apparaître la représentation. E — Faux. Une négation ordinaire ne suffit pas à identifier une défense.

Q78 — Réponses : D. A — Faux. Le mouvement décrit va vers l'extérieur, et non vers l'intériorisation. B — Faux. La projection ne se définit pas par cette décision consciente. C — Faux. Aucune élaboration humoristique de la difficulté n'est décrite. D — Vrai. Une représentation ou une tendance propre est attribuée à l'extérieur. E — Faux. La situation ne décrit pas de dérivation vers un but socialement valorisé.

Q79 — Réponses : C, E. A — Faux. Cette assimilation est incorrecte. B — Faux. La nuance témoigne au contraire d'une intégration possible des qualités et limites. C — Vrai. Il ne désigne pas une synthèse de ces attitudes. D — Faux. La dynamique doit être examinée sans conclusion automatique. E — Vrai. L'ambivalence est ainsi difficile à intégrer dans une représentation unifiée.

Q80 — Réponses : E. A — Faux. Il relève de l'apprentissage par observation. B — Faux. Aucun objet doté de qualités parfaites n'est décrit. C — Faux. Aucun acte opposé visant à effacer le précédent n'est présenté. D — Faux. Elle consiste à communiquer sur la communication. E — Vrai. L'objet de la tendance est modifié vers la personne propre.

Q81 — Réponses : A, B. A — Vrai. Elle ne suppose pas une incorporation matérielle. B — Vrai. Elle contribue notamment à la construction psychique. C — Faux. Elle participe aussi au développement ordinaire. D — Faux. Ils peuvent être inconscients. E — Faux. Cette dernière définition correspond à la projection.

Q82 — Réponses : A, C. A — Vrai. Son interprétation exige le contexte. B — Faux. La défense ne transfère pas cette responsabilité. C — Vrai. Le sujet peut reprendre des attributs, une conduite ou une position de l'agresseur. D — Faux. Elle peut fonctionner de manière inconsciente. E — Faux. Une défense ne constitue pas un consentement.

Corrigés argumentés — suite

Q83 — Réponses : E. A — Faux. L'idéalisation ne constitue pas un critère de guérison. B — Faux. La perfection absolue n'est pas une évaluation nuancée. C — Faux. Aucun souvenir précis et son destin ne sont établis. D — Faux. La situation ne décrit pas cette séparation. E — Vrai. Elle peut notamment protéger contre des affects hostiles ou une ambivalence difficiles à tolérer.

Q84 — Réponses : A, E. A — Vrai. Elle correspond à un retour à des modalités antérieures de fonctionnement. B — Faux. Comprendre le mécanisme n'abolit pas le respect de son autonomie. C — Faux. Cette conclusion dépasse les faits décrits. D — Faux. Le comportement actuel ne fournit pas cette preuve. E — Vrai. Elle ne signifie pas automatiquement une dégradation définitive.

Q85 — Réponses : A. A — Vrai. L'action sert à éviter la confrontation à des affects ou à des conflits. B — Faux. L'activité peut précisément servir à éviter cette angoisse. C — Faux. Le niveau d'activité ne suffit pas ; sa fonction défensive importe. D — Faux. Ce mécanisme ne définit pas la situation. E — Faux. Agir beaucoup n'implique pas une transformation sublimatoire.

Q86 — Réponses : C, E. A — Faux. La compréhension et l'élaboration affective ne se confondent pas. B — Faux. Elle décrit un mode de traitement psychique, et non un score intellectuel. C — Vrai. L'abondance de concepts peut protéger du vécu émotionnel. D — Faux. Une explication fondée n'est pas automatiquement une défense. E — Vrai. Sa fonction peut rester inconsciente.

Q87 — Réponses : D, E. A — Faux. Les deux mécanismes sont distincts. B — Faux. L'énergie peut être investie autrement. C — Faux. La fonction psychique ne se déduit pas du seul type d'activité. D — Vrai. Une relation affectueuse peut conserver l'objet tout en modifiant le but. E — Vrai. Elle est distinguée du refoulement dans la fiche.

Q88 — Réponses : A, B. A — Vrai. Il ne suppose pas d'humilier autrui. B — Vrai. Cela ne permet pas de réduire toute aide à autrui à une défense. C — Faux. Un comportement aidant n'est pas pathologique par nature. D — Faux. La moquerie ne définit pas cet usage de l'humour. E — Faux. Il peut coexister avec une détresse.

Q89 — Réponses : B. A — Faux. Cela correspond à la projection. B — Vrai. Cette stratégie est consciente, contrairement au refoulement. C — Faux. Cela correspond au refoulement dans le modèle. D — Faux. Cela évoque le clivage du Moi. E — Faux. Cela peut évoquer une formation réactionnelle.

Corrigés argumentés — suite

Transfert, observation et démarche clinique

Q90 — Réponses : A, C. A — Vrai. Le processus s'appuie sur des ressemblances et des attentes, souvent inconscientes. B — Faux. Sa définition est plus large. C — Vrai. Une valence positive n'est pas toujours uniquement favorable au travail. D — Faux. Il peut être présent dans d'autres relations, notamment de soin. E — Faux. Une dynamique transférentielle n'annule pas les faits à examiner.

Q91 — Réponses : D. A — Faux. Elle doit pouvoir être pensée et élaborée. B — Faux. Ce n'est pas la définition du concept. C — Faux. L'existence d'une réaction ne constitue pas à elle seule une faute. D — Vrai. Leur repérage aide à réfléchir à la relation de soin. E — Faux. Le soignant reste impliqué subjectivement.

Q92 — Réponses : C, D. A — Faux. Cela peut renforcer la division relationnelle. B — Faux. Le sens relationnel et la réalité des faits doivent être distingués. C — Vrai. Une hypothèse de clivage ne dispense pas d'évaluer une difficulté réelle. D — Vrai. Cette réflexion limite les réponses agies et les divisions. E — Faux. Une seule observation est insuffisante.

Q93 — Réponses : B, C, D. A — Faux. L'association descriptive ne fournit pas à elle seule une cause. B — Vrai. Il comporte une dimension subjective. C — Vrai. Il n'établit pas nécessairement une cause unique. D — Vrai. La sémiologie organise le recueil de ces manifestations. E — Faux. Un signe peut être observé sans plainte spontanée.

Q94 — Réponses : C. A — Faux. Elle concerne la description et le classement. B — Faux. La description clinique reste nécessaire. C — Vrai. Les deux démarches sont liées mais distinctes. D — Faux. Il ne remplace pas l'évaluation singulière. E — Faux. Elle interroge notamment la définition des maladies.

Q95 — Réponses : B, D. A — Faux. Il est défini par sa fonction psychique interne. B — Vrai. Ces avantages peuvent être conscients ou inconscients. C — Faux. Un avantage ne prouve pas que le symptôme est fabriqué. D — Vrai. Il relève de l'économie psychique du symptôme. E — Faux. Comprendre une fonction ne revient pas à la souhaiter.

Q96 — Réponses : A, B, C. A — Vrai. Une expression discrète ne garantit pas une faible gravité. B — Vrai. La signification d'une manifestation varie avec l'âge et la situation. C — Vrai. La labilité développementale justifie une évaluation évolutive et une aide précoce. D — Faux. Le signe est insuffisant à lui seul. E — Faux. Le repérage précoce peut permettre un accompagnement adapté.

Corrigés argumentés — suite

Q97 — Réponses : A, D, E. A — Vrai. Les regards complémentaires enrichissent l'évaluation et l'accompagnement. B — Faux. Les critères nécessitent une interprétation clinique. C — Faux. Les besoins et ressources de la personne doivent être considérés. D — Vrai. L'observation précède l'attribution diagnostique. E — Vrai. Le diagnostic ne résume pas tous les besoins.

Classifications et critères diagnostiques

Q98 — Réponses : B, C, E. A — Faux. Des classifications peuvent être descriptives. B — Vrai. Elle distingue notamment présence et absence d'un trouble défini. C — Vrai. Elle ne suppose pas que chaque détail du type soit présent. D — Faux. Le contexte et l'évaluation clinique restent nécessaires. E — Vrai. Elle ne se limite pas à une réponse oui-non.

Q99 — Réponses : A, C, E. A — Vrai. Des jugements concordants ne garantissent pas à eux seuls la validité. B — Faux. La cohérence d'une catégorie ne signifie pas absence de troubles associés. C — Vrai. Elle ne se réduit pas à l'accord entre évaluateurs. D — Faux. L'accord peut porter sur un classement discutable. E — Vrai. Un état qui change ne doit pas être confondu avec un simple défaut de mesure.

Q100 — Réponses : A, C. A — Vrai. Elle limite l'attribution du trouble aux personnes qui ne le présentent pas. B — Faux. Un outil doit aussi être pertinent pour la situation d'utilisation. C — Vrai. Elle favorise le repérage des personnes présentant réellement le trouble recherché. D — Faux. Le terme a ici un sens méthodologique. E — Faux. Cette situation est un faux négatif.

Q101 — Réponses : B, E. A — Faux. La durée et l'ensemble des critères ne sont pas réunis. B — Vrai. Un seul de ces deux symptômes peut satisfaire cette condition centrale. C — Faux. Le critère porte sur une même période. D — Faux. Le seuil est d'au moins cinq, sous les conditions précisées. E — Vrai. Ils représentent un changement par rapport au fonctionnement antérieur.

Q102 — Réponses : A, C, E. A — Vrai. Ils constituent deux domaines distincts. B — Faux. Elle ne figure pas parmi ces critères dépressifs. C — Vrai. Elle appartient aux critères décrits. D — Faux. Elle n'est pas requise pour définir tout épisode. E — Vrai. Elle ne se réduit pas au regret ordinaire d'être malade.

Corrigés argumentés — suite

Q103 — Réponses : C, D. A — Faux. Le critère ne se limite pas à la perte de poids. B — Faux. L'hypersomnie peut également être présente. C — Vrai. Le repère de variation pondérale ne rend pas obligatoire une perte de poids chez toute personne déprimée. D — Vrai. Il ne s'agit pas seulement d'une impression subjective d'agitation ou de lenteur. E — Faux. Le nombre, la durée, le retentissement et les autres conditions restent nécessaires.

Q104 — Réponses : C, E. A — Faux. Le calme apparent ne suffit pas à écarter une situation préoccupante. B — Faux. Le changement par rapport à l'état antérieur fait partie de l'évaluation. C — Vrai. Le domaine inclut aussi les idées suicidaires, projets ou tentatives selon les situations. D — Faux. Les idées peuvent exister sans projet organisé. E — Vrai. Le décompte seul ne suffit pas à décrire l'ensemble des critères.

Q105 — Réponses : A, B, C. A — Vrai. Un épisode dépressif peut aussi survenir dans un trouble bipolaire. B — Vrai. Il modifie le raisonnement diagnostique global. C — Vrai. L'attribution et les exclusions font partie de la démarche. D — Faux. Il peut exister des épisodes dépressifs dans la bipolarité. E — Faux. Le deuil exige une appréciation clinique ; il n'exclut ni ne confirme automatiquement l'épisode.

Q106 — Réponses : A, C, E. A — Vrai. Cette intention n'abolit pas tous les choix conceptuels du classement. B — Faux. Cette description correspond à la portée générale de la CIM. C — Vrai. Il s'agit d'une classification des troubles mentaux. D — Faux. La description diagnostique ne remplace pas une compréhension clinique globale. E — Vrai. La sévérité ou l'évolution peuvent être précisées.

Q107 — Réponses : B, C, E. A — Faux. Elle peut notamment traduire les limites des informations ou du classement disponibles. B — Vrai. Elle peut être partielle ou complète et survenir sous traitement. C — Vrai. Il ne signifie pas automatiquement absence de trouble. D — Faux. Ce n'est pas une condition générale de la notion. E — Vrai. Elle ne dépend pas d'un seul mot employé par le patient.

Q108 — Réponses : C, D. A — Faux. Le projet d'accompagnement dépasse ce seul diagnostic. B — Faux. La conclusion nécessite une évaluation. C — Vrai. Une classification n'exclut pas les comorbidités. D — Vrai. Le motif est une demande ou une raison de recours ; le diagnostic relève de l'évaluation. E — Faux. Plusieurs troubles peuvent réellement coexister.

Q109 — Réponses : C, D, E. A — Faux. La CIM relève de l'OMS ; le DSM de l'Association américaine de psychiatrie. B — Faux. Ce n'est pas son champ. C — Vrai. Son périmètre dépasse les troubles mentaux. D — Vrai. Le transcodage ne supprime pas leurs différences conceptuelles. E — Vrai. Elle prend en compte le développement et une lecture psychopathologique spécifique.

Corrigés argumentés — suite

Repères historiques et raisonnement transversal

Q110 — Réponses : D, E. A — Faux. Les systèmes historiques et actuels diffèrent. B — Faux. La description clinique reste indispensable. C — Faux. Il possède un sens théorique historique spécifique. D — Vrai. Il s'agit de termes historiques à replacer dans leur modèle. E — Vrai. Elles sont distinguées des névroses actuelles dans cette présentation.

Q111 — Réponses : C, D, E. A — Faux. Cette assimilation est incorrecte. B — Faux. Plusieurs évolutions sont possibles. C — Vrai. Cette terminologie appartient au classement historique présenté. D — Vrai. La dissociation n'est pas synonyme de double personnalité. E — Vrai. Son évolution peut être isolée, récidivante ou s'inscrire dans une évolution chronique.

Q112 — Réponses : B. A — Faux. Il renvoie à un effacement ou ralentissement progressif. B — Vrai. La temporalité de l'altération les distingue. C — Faux. L'observation doit être contextualisée et intégrée à un ensemble clinique. D — Faux. Ils concernent ici la sémiologie de la pensée et du discours. E — Faux. Ce n'est pas la définition sémiologique.

Q113 — Réponses : A, B, E. A — Vrai. Le terme ne se réduit pas à une tristesse poétique. B — Vrai. Il ne suppose pas que chaque symptôme soit un simple reflet indépendant d'une cause unique. C — Faux. Les modèles transversaux interrogent au contraire les processus partagés et les interactions. D — Faux. Les modèles servent le raisonnement clinique sans le remplacer. E — Vrai. Les approches processuelles interrogent ces dimensions transdiagnostiques.